Options d'ablation guidée par l'image pour les fibromatoses desmoïdes : preuves contemporaines et intégration aux recommandations

Titre original : Image-Guided Ablative Options for Desmoid Fibromatosis: Contemporary Evidence and Guideline Integration

Auteurs : Adamo DA, Schmitz JJ et al. | **Revue :** *Current treatment options in oncology* (**IF : 4.1**) | **Date :** Oct. 2026 | **PMID :** 42955498 | **Modalité :** Scanner TDM / IRM / Échographie

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

En lien direct avec les cryoablations de tumeurs desmoïdes (creux sus-claviculaire, paroi thoracique, paravertébral) et le suivi IRM en Radio B.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Mise au point de référence (*Curr Treat Options Oncol*, oct. 2026) détaillant l'intégration de la cryoablation percutanée dans l'algorithme multidisciplinaire des tumeurs desmoïdes symptomatiques ou progressives, incluant les stratégies d'ablation subtotale délibérée à proximité des nerfs critiques.

Analyse détaillée : Après surveillance active initiale, le traitement ablatif est indiqué en cas de douleur réfractaire, gêne fonctionnelle, progression soutenue ou menace sur les structures nobles. La cryoablation percutanée est la modalité de référence grâce à la visualisation directe de la boule de glace, la synergie multi-sondes pour sculpter la zone d'ablation et la possibilité de traitements séquentiels. L'article formalise le concept d'ablation subtotale délibérée ('deliberate subtotal ablation') lorsque l'objectif principal est l'antalgie et que l'obtention d'une marge circonférentielle complète menacerait un plexus nerveux, la peau ou le tube digestif. L'association séquentielle ou combinée aux traitements systémiques (inhibiteurs de gamma-sécrétase, TKIs) pour traiter un foyer dominant symptomatique est également détaillée.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Discussion en RCP Sarcomes/Desmoïdes • Planification IRM T2/DWI/T1 injecté • Cryoablation multi-sondes sous TDM/IRM avec hydrodissection, réchauffement cutané actif et neuromonitoring • Visée complète (A0) si marges sûres, ou debulking subtotal délibéré au contact des troncs nerveux.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- La cryoablation percutanée est la modalité ablative de choix dans les tumeurs desmoïdes grâce au contrôle visuel de la boule de glace.
- Validation du concept d'ablation subtotale délibérée à visée antalgique/fonctionnelle lorsque la tumeur jouxte un plexus nerveux majeur.
- Complémentarité entre thérapie systémique et cryoablation focale sur un contingent résiduel douloureux ou progressif ('oligoprogression').
- Rôle essentiel de l'hydrodissection, du réchauffement cutané et de la protection nerveuse active.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Opinion statement Most patients with a newly diagnosed desmoid tumor should begin with multidisciplinary evaluation and active surveillance rather than immediate intervention, provided that symptoms are limited and further growth is unlikely to create irreversible morbidity. Treatment should be initiated when pain, functional limitation, sustained progression, or threatened critical structures make continued observation unacceptable.

Percutaneous cryoablation is generally favored because the ice ball can be monitored directly, treatment can be personalized/tailored with the synergistic benefit of multiple probes, and the procedure can be repeated or staged when a complete margin would be unsafe. Complete ablation should be targeted when the entire tumor can be covered without jeopardizing skin, nerves, bowel, or other vulnerable structures; deliberate subtotal ablation is appropriate when the principal goal is pain relief or functional improvement and a safe circumferential margin is not achievable. Hydrodissection, skin warming, neural protection, and conservative treatment near critical anatomy are essential. Magnetic resonance-guided focused ultrasound is an attractive incisionless alternative for tumors with a favorable acoustic window. Microwave or radiofrequency ablation should be reserved for carefully selected lesions and experienced operators; electrochemotherapy and chemical ablation remain investigational with some promising early evidence. Embolization can be useful for hypervascular tumors that are poorly suited to direct percutaneous treatment. Local and systemic therapy should not be viewed as mutually exclusive: systemic treatment is often preferable for diffuse, intra-abdominal, or anatomically hazardous disease, while ablation can address a dominant symptomatic focus, residual viable tumor, or focal progression. Further study into the benefits and sequencing of combining local therapy with systemic or targeted options will be helpful in the multi-disciplinary evaluation of this complex patient cohort.